8 Politiche del farmaco: un approfondimento sull'innovatività terapeutica[1]

di Patrizio Armeni, Ludovico Cavallaro, Francesco Costa, Monica Otto

8.1 Introduzione e trend di spesa farmaceutica

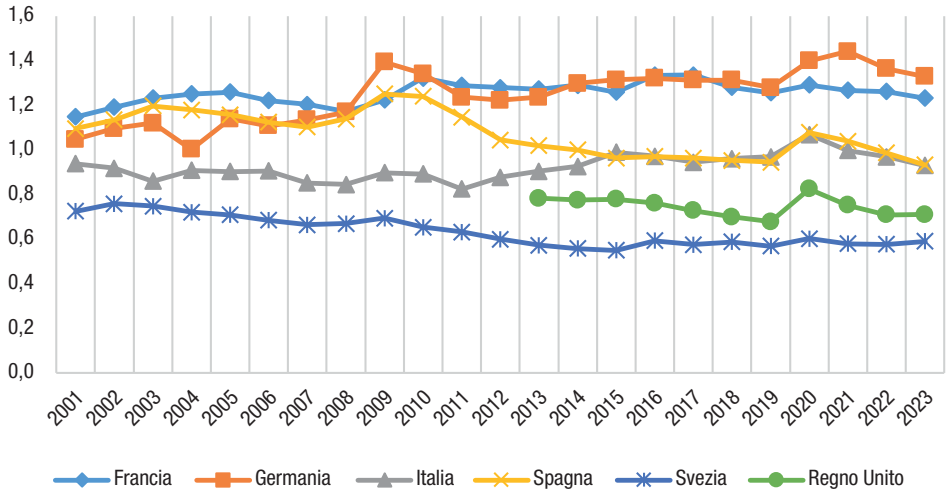
Governare e gestire l'assistenza farmaceutica significa saper garantire un accesso equo ed economicamente sostenibile ai farmaci. Spesso tale sfida si è tradotta nel contesto italiano in azioni volte al controllo (o contenimento) della spesa farmaceutica (Armeni, Costa, Otto, *et al.*, 2023), ma ha anche stimolato lo sviluppo e la graduale diffusione di approcci e metodi volti alla misurazione del valore delle tecnologie sanitarie allo scopo di assumere decisioni sempre più *evidence-based*.

Nel confronto con i principali Paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia), secondo gli ultimi dati disponibili dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel 2023 l'incidenza della spesa farmaceutica pubblica italiana sul PIL si è attestata allo 0,93%, in linea con i livelli osservati nel periodo prepandemico (Figura 8.1). A livello comparativo, Francia e Germania presentano valori stabilmente superiori (oltre l'1,2%). La Spagna registra un andamento analogo a quello italiano a partire dal 2015, con livelli sostanzialmente coincidenti nell'ultimo triennio. Regno Unito e Svezia continuano, invece, a presentare incidenze inferiori.

Secondo i dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Osservatorio Farmaci (OSFAR) del CERGAS – SDA Bocconi, nel lungo periodo (2001-2024) la spesa farmaceutica pubblica in Italia ha mostrato un andamento di crescita più contenuto rispetto al complesso della spesa sanitaria pubblica. La spesa farmaceutica è aumentata in media del 2,56% all'anno, a fronte di un

[1] Il presente capitolo presenta i risultati di una ricerca condotta dall'Osservatorio Farmaci (OSFAR) del CERGAS-SDA Bocconi. Fondato nel 1997, al momento della pubblicazione, OSFAR è supportato da Galderma, Ipsen, UCB, Viatris. Sebbene il capitolo sia il frutto di un lavoro comune di ricerca, i contributi specifici sono così attribuiti: il § 8.1 a Monica Otto e Ludovico Cavallaro, il § 8.2 a Francesco Costa e Monica Otto, il § 8.3 a Patrizio Armeni, il § 8.4 a tutti gli autori.

Figura 8.1 **Spesa farmaceutica pubblica* in rapporto al PIL nei principali Paesi europei (2001-2023)**



Note: i) La spesa farmaceutica pubblica include la spesa sostenuta per l'acquisto di farmaci con prescrizione e di altri beni medici non durevoli; ii) I dati relativi al Regno Unito sono disponibili a partire dal 2013, poiché le serie precedenti non sono rese disponibili dalla fonte OCSE.

Fonte: Elaborazioni OSFAR su dati OCSE, 2025

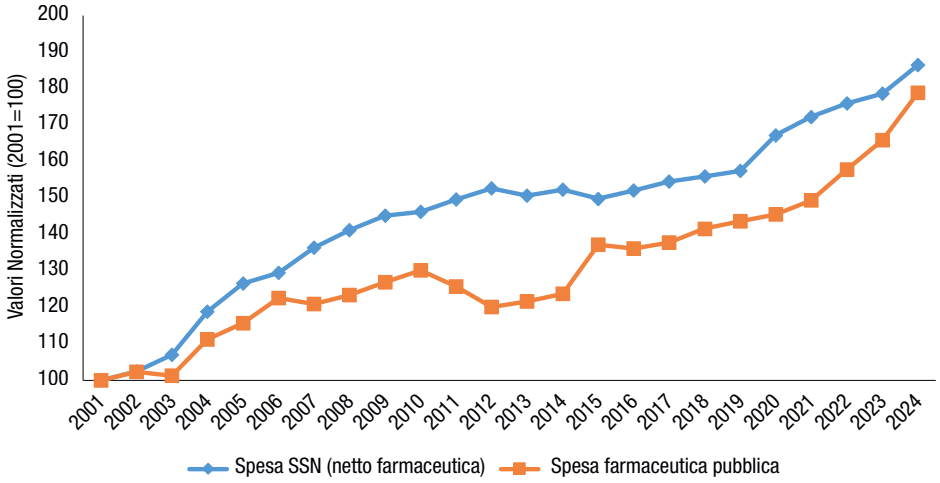
incremento medio del 2,75% per la spesa sanitaria al netto della componente farmaceutica (Figura 8.2). Questa diversa dinamica di crescita ha determinato, nel tempo, una lieve riduzione dell'incidenza della spesa farmaceutica sul totale della spesa sanitaria pubblica, che è passata dal 18,2% nel 2001 al 17,6% nel 2024 (Figura 8.3).

Considerando un orizzonte temporale più breve, compreso tra il 2016 e il 2024, emerge, invece, una tendenza opposta. In questi anni, la spesa farmaceutica pubblica è cresciuta con un tasso medio annuo del 3,5%, superiore al 2,6% registrato per la spesa sanitaria al netto della componente farmaceutica (Figura 8.2). L'effetto complessivo è un incremento dell'incidenza della spesa farmaceutica sul totale della spesa sanitaria, che risale dal 16,6% al 17,6% (Figura 8.3).

Va tuttavia considerato l'impatto dei diversi meccanismi di *payback*, in particolare quello relativo ai rimborsi versati dalle aziende farmaceutiche per il superamento del tetto di spesa per gli acquisti diretti (Armeni, Callea, Costa, *et al.*, 2023). Tra il 2016 e il 2024 tali restituzioni hanno inciso in media per circa l'1,75% della spesa sanitaria pubblica, contribuendo a ridurre il peso netto della spesa farmaceutica sul totale (Figura 8.4).

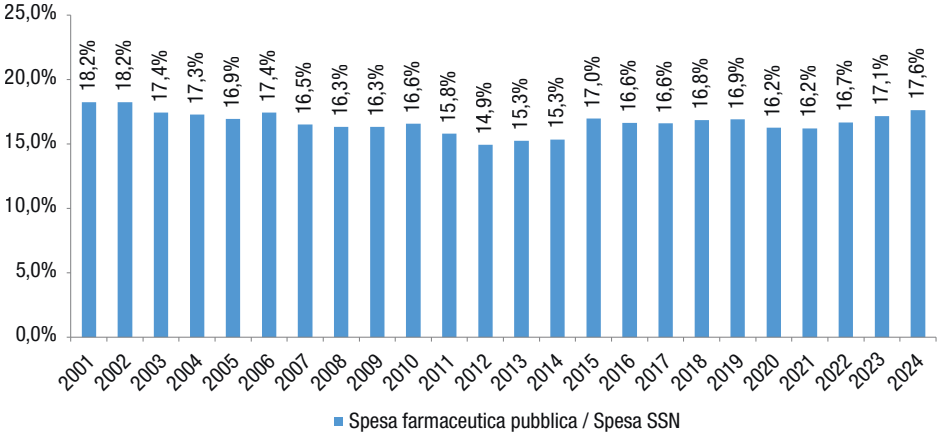
Con specifico riferimento alla composizione della spesa farmaceutica pubblica, la componente che incide maggiormente è quella per gli acquisti diretti (spesa per farmaci acquistati dalle aziende sanitarie pubbliche) rispetto alla

Figura 8.2 **Trend della spesa sanitaria pubblica (netto farmaceutica) e della spesa farmaceutica pubblica (2001-2024; 2001=100)**



Fonte: Elaborazioni OSFAR su dati AIFA e Ministero della Salute; 2025

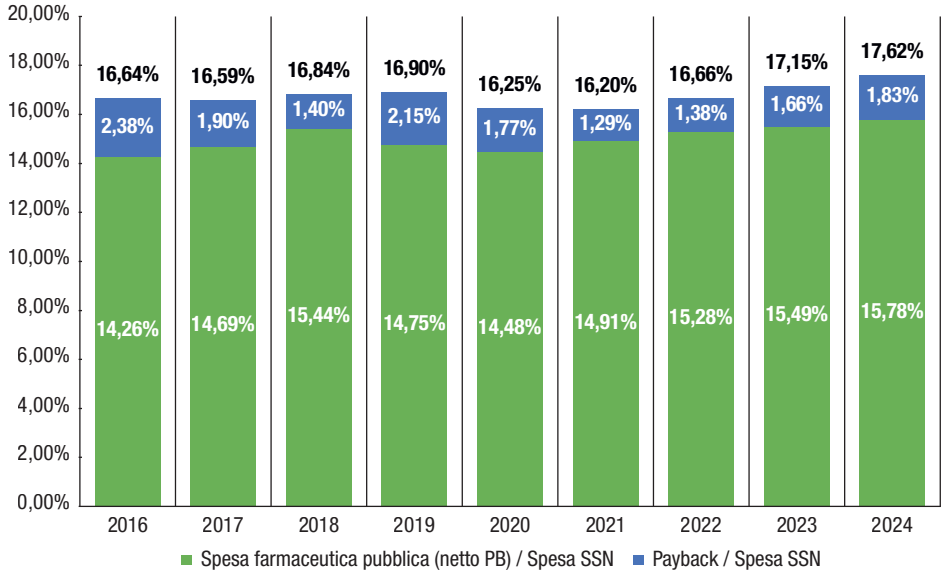
Figura 8.3 **Incidenza della spesa farmaceutica pubblica sulla spesa sanitaria pubblica (2001-2024)**



Fonte: Elaborazioni OSFAR su dati AIFA e Ministero della Salute, 2025

convenzionata (spesa per farmaci che transitano dalle farmacie aperte al pubblico, ad esclusione della distribuzione in nome e per conto). Ciò si conferma anche a livello regionale, seppur con una certa eterogeneità: gli acquisti di farmaci da parte delle aziende sanitarie pubbliche risultano avere un'incidenza maggiore nel Centro-Nord (tra il 68,5% nel Centro ed il 68% nel Nord), che al Sud e Isole (67,5%) (Figura 8.5).

Figura 8.4 **Incidenza della spesa farmaceutica pubblica e dei payback* sulla spesa sanitaria pubblica (2016-2024)**



Note: ii) *payback* considerati includono sia le componenti relative alla spesa farmaceutica convenzionata sia quelle riferite agli acquisti diretti. Per la spesa convenzionata di fascia A sono stati inclusi il *payback* dell'1,83%, il *payback* del 5%, il ripiano per gli sfondamenti dei tetti di prodotto, le retrocessioni e il *payback* di manovra. Per gli acquisti diretti sono stati invece considerati il *payback* del 5% per i farmaci non convenzionati di fascia A e H, il ripiano per gli sfondamenti dei tetti di prodotto delle medesime fasce, le eccedenze rispetto agli accordi negoziali prezzo/volume, le note di credito connesse a tali accordi e i *Managed Entry Agreements* per i farmaci di fascia A e H. Per quanto riguarda i *payback* relativi al ripiano della spesa per acquisti diretti a seguito di sfondamento del tetto di spesa, i valori sono stati ottenuti dalle determine dell'AIFA, ad eccezione dell'anno 2024, per il quale l'importo è stato stimato ipotizzando un recupero pari al 50% dello sfondamento complessivo.

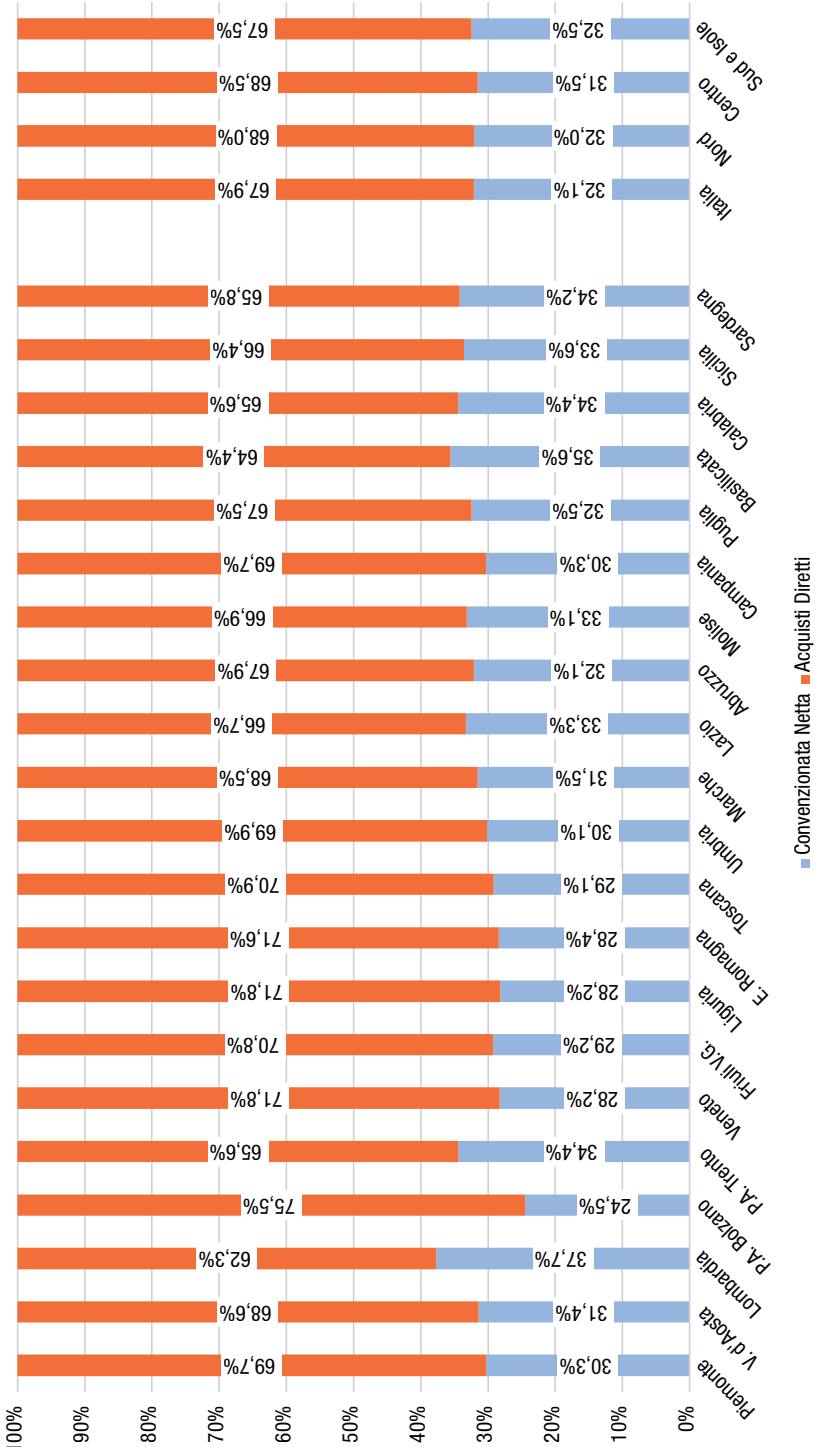
Fonte: Elaborazioni OSFAR su dati AIFA e Ministero della Salute; 2025

Da un confronto storico dei dati di spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti rispetto ai relativi tetti (Armeni, Costa, Otto, *et al.*, 2023), emerge un trend piuttosto costante per entrambe le componenti. La spesa convenzionata si mantiene su livelli prossimi al tetto programmato, mentre la spesa per acquisti diretti continua a sfondarlo in modo sistematico e consistente. Questo scostamento ricorrente segnala un evidente sottodimensionamento del livello di finanziamento assegnato alla componente degli acquisti diretti, non sufficientemente bilanciato dalla presenza dei fondi per i farmaci innovativi (Tabella 8.1 e Figura 8.6).

La necessità di superare i sistemi di contingentamento della spesa a favore di una programmazione solida, lungimirante e basata sul valore è già stata ampiamente sostenuta dall'OSFAR (Armeni, Costa, Otto, *et al.*, 2023) e da altri ricercatori CERGAS (Armeni, Callea, Costa, *et al.*, 2023).

Dopo aver analizzato i principali trend della spesa farmaceutica pubblica, il presente capitolo approfondisce il recente sviluppo delle politiche del farmaco

Figura 8.5 **Composizione della spesa farmaceutica pubblica a livello regionale e di macroregioni (2024)**



Fonte: Elaborazioni OSFAR su dati AIFA (Distinte Contabili Riepilogative per la spesa convenzionata netta e Conti Economici per la spesa per acquisti diretti), 2025.

Tabella 8.1 **Trend della spesa farmaceutica (convenzionata e acquisti diretti), tetto e relativo sfondamento (2008-2024)**

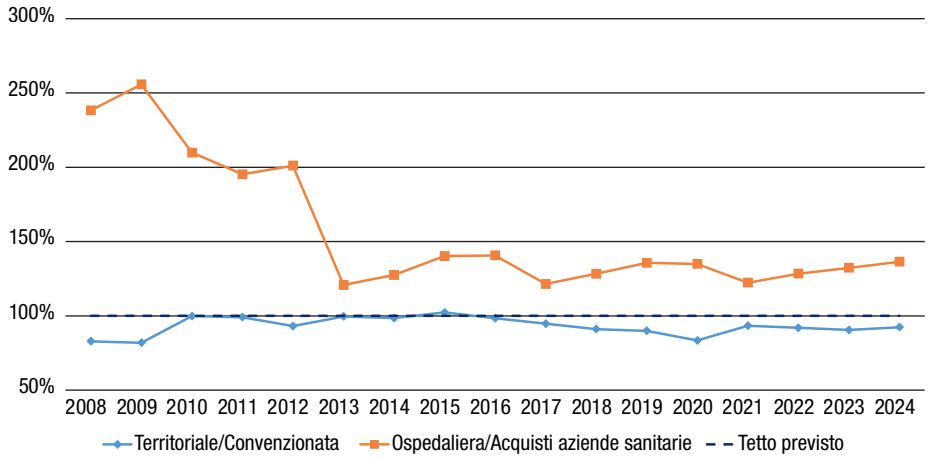
Tetto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Territoriale/ Convenzionata	13.739	13.744	13.965	14.133	14.039	12.128	12.402	12.380	12.522	8.907	8.977	9.058	9.518	8.465	8.723	8.931	9.045
Ospedaliera/Acquisti aziende sanitarie	2.355	2.425	2.520	2.550	2.572	3.724	3.824	3.818	3.862	7.709	7.770	7.613	7.999	9.251	9.533	10.143	11.040
Spesa																	
Territoriale/ Convenzionata	11.384	11.253	13.941	14.006	13.070	12.078	12.217	12.666	12.317	8.435	8.174	8.144	7.940	7.904	8.017	8.084	8.353
Ospedaliera/Acquisti aziende sanitarie	5.614	6.203	5.288	4.980	5.171	4.498	4.874	5.353	5.432	9.361	9.972	10.328	10.791	11.318	12.239	13.422	15.056
Scostamento																	
Territoriale/ Convenzionata	-2.355	-2.492	-24	-127	-969	-50	-185	286	-205	-472	-803	-914	-1.578	-561	-706	-847	-691
Ospedaliera/Acquisti aziende sanitarie	3.259	3.778	2.768	2.429	2.599	773	1.050	1.535	1.571	1.652	2.202	2.715	2.792	2.067	2.706	3.279	4.016

Nota: dal 2008 al 2016 i tetti si riferiscono alla spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera e dal 2017 alla spesa farmaceutica convenzionata ed acquisti diretti.

* La spesa per acquisti diretti è al netto della spesa per gas medicinali e lo scostamento è calcolato sul tetto del 6,69% (2019-2020), 7,65% (2021-2022), 7,95% (2023) e 8,30% (2024) come riportato nei monitoraggi AIFA.

Fonte: Elaborazioni OSFAR su dati AIFA, 2025

Figura 8.6 **Incidenza della spesa farmaceutica pubblica sui rispettivi tetti (2008-2024)**



Nota: iii) Si ricorda che: i) nel 2012 è stato innalzato il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera dal 2,4% al 3,5% del FSN; ii) nel 2017 è stata introdotta una revisione del sistema dei tetti di spesa, con il passaggio dalla spesa farmaceutica territoriale alla spesa convenzionata e dalla spesa ospedaliera agli acquisti diretti.

Fonte: Elaborazioni OSFAR su dati AIFA; 2025

in Italia e il loro impatto sull'assetto regolatorio e decisionale, nonché il tema dell'innovatività in ambito farmaceutico. In particolare, intende:

- esaminare le politiche e gli aggiornamenti introdotti a livello nazionale nel corso del 2025, valutandone le implicazioni per la programmazione e la sostenibilità del sistema (cfr. §8.2);
- delineare l'evoluzione del framework di valutazione dell'innovatività terapeutica, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e della nuova Determina AIFA 955-2025, confrontandolo con i principali approcci europei e internazionali (cfr. §8.3);
- formulare alcune raccomandazioni di policy rivolte ai decisori pubblici e agli attori del settore, volte a rafforzare l'integrazione dei criteri di valore nei processi di prezzo, rimborso e accesso ai farmaci innovativi (cfr. §8.4).

8.2 Processi decisionali e aggiornamenti delle politiche del farmaco in Italia

La spesa farmaceutica pubblica è sempre stata una voce di grande interesse per i *policymaker*. Tale attenzione è principalmente attribuibile agli elevati livelli di spesa che ogni anno vengono generati per l'acquisto di farmaci (cfr. supra),

nonché alla facilità di alcune politiche nel generare un contenimento dei costi in breve tempo (vedi politiche sui diversi *payback* farmaceutici). È pertanto obiettivo del *policymaker* riuscire a coniugare, attraverso la formulazione di politiche del farmaco efficaci, la generazione di valore nel percorso di assistenza dei cittadini e l'efficienza nell'allocazione di risorse pubbliche.

Come già discusso ampiamente in pregresse edizioni di questo rapporto (Amoroso, Armeni, Costa, *et al.*, 2016; Armeni, Costa, Otto, *et al.*, 2023), le politiche del farmaco possono essere formulate e applicate a diversi livelli di governo: nazionale, regionale e locale. In questo paragrafo, piuttosto che soffermarsi sugli aspetti tecnici legati alle iniziative in ambito farmaceutico, si vuole fornire un aggiornamento sulle principali politiche del farmaco che sono state introdotte dall'inizio del 2025. Per maggiori approfondimenti sui principi che guidano tali politiche, si rimanda al capitolo 10 del Rapporto OASI 2016 (Amoroso, Armeni, Costa, *et al.*, 2016) e al capitolo 8 del Rapporto OASI 2023 (Armeni, Costa, Otto, *et al.*, 2023).

8.2.1 Il livello di finanziamento 2025

Con riferimento al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard[2], la Legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha disposto uno stanziamento complessivo pari a: 136,5 miliardi di euro per il 2025, 140,6 miliardi di euro per il 2026 e 141,3 miliardi di euro per il 2027. Tali importi derivano da un incremento rispetto alla precedente Legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), attraverso risorse aggiuntive pari a 1,3 miliardi di euro per il 2025, 5 miliardi per il 2026 e 5,7 miliardi per il 2027. Questa dinamica riflette una variazione nominale, più che un effettivo incremento in termini reali, coerente con gli obiettivi di consolidamento delle finanze pubbliche e con i vincoli introdotti dal nuovo Patto di stabilità europeo.

Per quanto riguarda la componente farmaceutica, la Legge di bilancio 2025 ha confermato la ripartizione interna del finanziamento già definita dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 223), mantenendo invariati i tetti di spesa: 6,8% per la spesa convenzionata e 8,5% per gli acquisti diretti, all'interno dei quali è ricompresa la quota dello 0,2% destinata ai gas medicinali. Tale conferma recepisce la trasformazione strutturale del mix di spesa osservata negli ultimi due decenni, caratterizzata da una progressiva riduzione della spesa convenzionata e da un incremento della spesa per acquisti diretti, ma non risolve la già citata asimmetria tra fabbisogni e limiti programmati, che continua a generare pressioni sulla componente sia

[2] Si ricorda che le risorse a disposizione per l'assistenza farmaceutica sono calcolate come percentuali del finanziamento complessivo per la sanità.

ospedaliera che territoriale della farmaceutica pubblica (cfr. supra).

Una novità introdotta dalla Legge di bilancio 2025 riguarda la ridefinizione della suddivisione interna del Fondo Farmaci Innovativi (FFI), la cui dotazione complessiva resta invariata a 1,3 miliardi di euro annui. La norma prevede la ripartizione delle risorse in tre componenti: 900 milioni destinati ai farmaci con innovatività piena, 300 milioni ai farmaci con innovatività condizionata (già valutati) e 100 milioni riservati agli antibiotici classificati come "*reserve*" e "*listed*". La revisione, adottata in una fase antecedente al licenziamento dei nuovi criteri di valutazione dell'innovatività terapeutica (cfr. infra), si inserisce in un percorso di progressivo allineamento tra strumenti di finanziamento e criteri regolatori, la cui piena coerenza richiede ulteriori interventi di definizione e armonizzazione.

8.2.2 Le forme alternative di distribuzione dei farmaci: revisione del PHT

La Legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti riforme in merito alla distribuzione dei farmaci (Armeni, Cavallaro, Costa, *et al.*, 2024), in termini di:

- modalità di remunerazione delle farmacie convenzionate, introducendo un sistema misto in cui la quota di spettanza è calcolata sia sulla base del prezzo al pubblico della specialità medicinale sia attraverso un sistema di quote fisse;
- aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT o prontuario della distribuzione diretta e della distribuzione in nome e per conto).

In particolare, rispetto a quest'ultimo punto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di bilancio, la Commissione Scientifica ed Economica (CSE, cfr. infra) dell'AIFA, con la determinazione del 3 maggio 2024 (AIFA, 2024), ha provveduto all'aggiornamento del PHT individuando come classe farmacologica oggetto di riclassificazione le gliptine, una categoria di antidiabetici orali per le quali sussistono i criteri per favorirne l'accesso in termini di prossimità attraverso le farmacie territoriali.

La stima dell'impatto prodotto sulla spesa farmaceutica pubblica della riclassificazione delle gliptine da A-PHT a classe A è stato oggetto di discussione tra AIFA e le Regioni. Al fine di superare tali divergenze, il tavolo tecnico AIFA-Regioni ha stabilito, il 15 aprile 2025, un metodo condiviso per la valutazione dell'impatto economico della riclassificazione delle classi farmacologiche. Il nuovo metodo è stato applicato, in particolare, con riferimento alle gliflozine (SGLT 2-inibitori, una classe di farmaci antidiabetici orali usati principalmente per trattare il diabete di tipo 2), che dal 19 luglio 2025 rappresentano la successiva classe terapeutica oggetto di riclassificazione dalla distribuzione diretta

a quella convenzionata (AIFA, 2025a). Con l'obiettivo di favorire l'aderenza terapeutica e la vicinanza del farmaco al paziente, il 30 giugno 2025 l'AIFA ha quindi comunicato l'approvazione della riclassificazione delle gliflozine nella fascia A, con passaggio alla distribuzione in convenzione tramite farmacia, e ha contemporaneamente abolito i Piani terapeutici per tali farmaci.

8.2.3 Il vecchio sistema di attribuzione del label di indicazione innovativa e gli aggiornamenti nella Legge finanziaria per il 2025

Con la Determina n. 1535 del 2017 (AIFA, 2017) è stato introdotto un sistema di valutazione dell'innovatività terapeutica più semplice ed *evidence based* rispetto all'algoritmo utilizzato fino a quel momento. A partire da tale atto normativo, il concetto di "farmaco innovativo" nel contesto regolatorio italiano fa riferimento ad un riconoscimento ufficiale rilasciato dall'AIFA, volto a premiare quei medicinali che, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili, apportano un beneficio clinico significativo in aree terapeutiche di particolare gravità. In questo contesto, il riconoscimento dell'innovatività non coincide automaticamente né con l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) né con l'ammissione alla rimborsabilità del farmaco, ma costituisce una procedura autonoma, sebbene basata sulle medesime evidenze scientifiche.

L'attribuzione di tale status, riferito a una singola indicazione, ha l'obiettivo di garantire un accesso rapido e uniforme sul territorio nazionale a farmaci ad alto valore terapeutico aggiunto e, contestualmente, di incentivare lo sviluppo di nuove terapie potenzialmente capaci di modificare in modo significativo la storia naturale della malattia. Il riconoscimento del carattere di innovatività è effettuato dall'AIFA su proposta della CSE, che elabora una valutazione articolata su tre assi fondamentali: 1) il bisogno terapeutico, 2) il valore terapeutico aggiunto e 3) la qualità delle prove scientifiche presentate.

La richiesta di innovatività viene formalmente presentata dall'azienda produttrice all'AIFA attraverso un apposito modulo predisposto dall'Agenzia, che guida il richiedente nella raccolta e nella presentazione delle informazioni necessarie. La decisione sull'innovatività viene presa dopo la valutazione congiunta dei tre criteri menzionati, secondo un modello multidimensionale e gerarchico.

Il bisogno terapeutico rappresenta il primo asse valutativo e riflette la necessità di nuove opzioni terapeutiche per una determinata indicazione. Questo parametro, a seconda della disponibilità e dell'efficacia clinica delle terapie già esistenti, è classificato su cinque livelli: i) massimo, ii) importante, iii) moderato, iv) scarso e v) assente. Ad esempio, un bisogno terapeutico "massimo" si verifica in assenza totale di trattamenti disponibili, mentre un livello "assente" indica la presenza di valide alternative terapeutiche capaci di modificare significativamente il decorso della malattia.

Il secondo criterio è il valore terapeutico aggiunto, ovvero il beneficio clini-

co dimostrato dal nuovo farmaco rispetto alle alternative disponibili. Anche questo parametro è suddiviso in cinque livelli – massimo, importante, moderato, scarso e assente – e tiene conto di esiti clinicamente rilevanti e validati. Nei farmaci oncologici, ad esempio, il *gold standard* è rappresentato dalla sopravvivenza globale (*overall survival*, OS), anche se possono essere accettati altri esiti surrogati (*progression-free survival*, PFS, *disease-free survival*, DFS) a seconda del contesto clinico.

Il terzo asse della valutazione è rappresentato dalla qualità delle prove, che riflette la robustezza metodologica degli studi presentati. L'AIFA adotta per questo parametro il sistema GRADE, che classifica le evidenze in quattro categorie: i) alta, ii) moderata, iii) bassa e iv) molto bassa. Un'evidenza di qualità alta è generalmente richiesta per ottenere il riconoscimento pieno dell'innovatività, anche se per i farmaci destinati a malattie rare l'Agenzia può accettare evidenze di qualità inferiore, in virtù delle oggettive difficoltà metodologiche nel condurre studi di ampie dimensioni in tali popolazioni di pazienti.

Sulla base della combinazione di questi tre criteri, la CSE formula un giudizio finale. Il riconoscimento pieno dell'innovatività è possibile solo se il farmaco ottiene almeno un livello "massimo" o "importante" sia per il bisogno terapeutico che per il valore terapeutico aggiunto, e contemporaneamente una qualità delle prove "alta". In situazioni intermedie, la CSE può valutare caso per caso, eventualmente attribuendo un'innovatività condizionata (o "potenziale"), che dà accesso a benefici limitati e prevede una rivalutazione obbligatoria entro 18 mesi. Al contrario, l'innovatività non può essere riconosciuta se anche soltanto uno dei tre criteri risulta "scarso" o "assente", o se la qualità delle prove è "bassa" o "molto bassa", salvo eccezioni per i farmaci orfani.

Il giudizio finale può assumere tre forme: 1) riconoscimento pieno dell'innovatività, 2) riconoscimento condizionato o 3) diniego del riconoscimento. In caso di riconoscimento pieno, il farmaco accede al FFI, ottiene benefici economici secondo la Legge di bilancio 2017 e viene automaticamente inserito nei Prontuari Terapeutici Regionali entro tempi definiti. La durata massima dei benefici connessi al riconoscimento dell'innovatività è pari a 36 mesi, al termine dei quali può essere prevista una rivalutazione in base alle nuove evidenze disponibili.

Infine, AIFA distingue tra "first in class" e "followers" nel riconoscimento dell'innovatività: il primo farmaco di una nuova classe terapeutica può godere del beneficio pieno per tre anni, mentre i successivi eventuali "followers" potranno beneficiare del riconoscimento per il tempo residuo.

A fine 2024, la Legge di bilancio per il 2025 (L. 207/2024) ha riaperto il tema della valutazione dell'innovatività di un'indicazione farmaceutica. L'atto normativo ha confermato e rafforzato l'importanza strategica del riconoscimento dell'innovatività terapeutica, recependo e integrando i criteri già adottati dall'AIFA. In particolare, il comma 281 ha chiarito che la valutazione

dell'innovatività non si basa soltanto sui risultati clinici, ma considera una serie di aspetti che vanno dalla tecnologia di produzione del principio attivo al suo meccanismo d'azione, fino alla modalità di somministrazione, l'impatto sulla qualità della vita dei pazienti e le implicazioni organizzative per il sistema sanitario.

Il comma 282 ha aggiunto che un farmaco può essere considerato innovativo solo se dimostra un beneficio concreto in termini di efficacia e sicurezza rispetto alle opzioni già presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, in riferimento a una specifica indicazione terapeutica.

Il comma 285 ha affidato all'AIFA il compito di definire, entro il 31 marzo 2025, i criteri ufficiali per l'attribuzione del carattere di innovatività.

Infine, i cc 288 e 289 della stessa Legge recitano che «A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al Fondo per un importo, comunque, non superiore a 300 milioni di euro annui. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse del Fondo per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui, possono essere utilizzate anche in relazione agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già iscritti o inseriti successivamente a tale data nel prontuario farmaceutico nazionale e classificati come reserve» (cfr 8.2.4).

Sulla scia di questa rivisitazione del sistema di attribuzione dell'innovatività terapeutica, quanto riportato dalla Determina n. 1535 del 2017 (AIFA, 2017) è stato sostituito con la Determina Pres. 966-2025 (AIFA, 2025c) pubblicata dall'AIFA nel luglio 2025 dopo la consultazione pubblica con i principali portatori di interesse (*cfr. infra*).

8.2.4 Dalla consultazione pubblica AIFA sui criteri di attribuzione dell'innovatività terapeutica alla nuova determina AIFA Pres. 966-2025

Dopo aver illustrato la versione dei criteri introdotti nel 2017 (cfr. supra), in questo paragrafo si analizza il nuovo quadro regolatorio proposto dall'AIFA a seguito delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2025. In linea con quanto anticipato nella Legge finanziaria, l'AIFA, il 12 marzo 2025, ha aperto una consultazione pubblica sui criteri di attribuzione dell'innovatività terapeutica al fine di raccogliere contributi da parte di tutti i portatori di interesse. Il documento tecnico (AIFA, 2025b) consolida la struttura già esistente, ma introduce alcune importanti modifiche metodologiche e sostanziali che sono state valutate e commentate da esperti in politiche farmaceutiche che hanno partecipato alla consultazione promossa dall'AIFA. Il CERGAS – SDA Bocconi ha partecipato alla consultazione pubblica inviando un memorandum contenente delle raccomandazioni per l'Agenzia in merito al documento condiviso.

Nel passaggio dal documento iniziale proposto dall'AIFA nel marzo 2025

a quanto riportato negli allegati alla Determina Presidenziale n. 966/2025, l'AIFA ha operato un'evoluzione normativa che non si traduce in una semplice bozza, bensì in un affinamento concettuale e operativo. I criteri introdotti in forma preliminare – frutto di un'elaborazione tecnico-scientifica interna – trovano nella determina presidenziale una codificazione definitiva e formalmente vincolante. Il percorso, infatti, si è completato attraverso la consultazione pubblica che ha dato modo ad associazioni di pazienti, società scientifiche e attori istituzionali di intervenire, contribuendo al consolidamento di una cornice valutativa multidimensionale e coerente con le esigenze del sistema salute.

Rispetto a quanto già in vigore precedentemente (Determina 1535/2017), i tre domini fondamentali – bisogno terapeutico, vantaggio terapeutico aggiunto (non più valore terapeutico) e qualità delle prove – vengono pienamente confermati nella loro struttura e nella funzione loro attribuita all'interno del processo di valutazione. Inoltre, l'articolazione dei livelli rimane invariata rispetto alla proposta iniziale presentata nel documento in consultazione. Nello specifico:

- Il bisogno terapeutico (determinato dalla necessità di terapie utili nel trattamento di una malattia o condizione patologica per la quale non sono disponibili opzioni terapeutiche, ovvero quando quelle eventualmente disponibili presentano un profilo di efficacia/sicurezza non soddisfacente) è graduato in cinque livelli (massimo, importante, moderato, minore, assente), con definizioni precise basate sulla disponibilità e sull'efficacia delle alternative.
- Il vantaggio terapeutico aggiunto (determinato dal beneficio clinico, e dalla sua entità, su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto, e dal beneficio complessivamente apportato dal farmaco in valutazione rispetto alle alternative disponibili, qualora presenti, all'interno del Prontuario Farmaceutico Nazionale prima della sua introduzione) viene anch'esso classificato su cinque livelli da "massimo" ad "assente", con attenzione al tipo di esiti clinici considerati (esiti surrogati rispetto ad esiti clinicamente rilevanti), alla dimensione dell'effetto e alla popolazione interessata. Viene richiamato, inoltre, seppure in maniera non approfondita, il concetto di qualità della vita come elemento da valutare in questa dimensione.
- La qualità delle prove, definita secondo la metodologia GRADE e includendo anche riferimenti alla trasferibilità dei risultati alla pratica clinica italiana, è classificata in quattro livelli (alta, moderata, bassa, molto bassa). In questa dimensione, viene inoltre richiamato il disegno dello studio a supporto delle evidenze, introducendo un'importante distinzione metodologica tra comparazioni indirette "ancorate" (valutate come randomizzate) e quelle non ancorate, equiparate a studi osservazionali.

L'innovatività è riconosciuta, per un massimo di 36 mesi[3] non prorogabile, alla singola indicazione terapeutica in presenza di un bisogno terapeutico, un vantaggio terapeutico aggiunto e una qualità delle prove di livello almeno "moderato". Nel caso di medicinali per malattie rare e ultra-rare, l'innovatività terapeutica potrà essere valutata anche in presenza di una qualità delle prove "bassa".

I benefici associati all'attribuzione del *label* di indicazione innovativa sono:

1. accesso alle risorse del FFI istituito ai sensi dell'art. 1, comma 401, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr 8.2.1);
2. sospensione delle riduzioni di legge sul prezzo dei farmaci rimborsabili di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006 (5% + 5%). Si precisa che i farmaci a cui è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata e che sono considerati innovativi dal primo gennaio 2025, non godranno automaticamente del beneficio di cui al presente punto, fermo restando che l'azienda titolare del medicinale avrà la facoltà di presentare istanza di rinegoziazione ai sensi della normativa vigente.
3. inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189;
4. esclusione, ai sensi dei commi 577 e 578, dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018, dal calcolo dell'ammontare complessivo della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti ai fini del rilevamento del superamento del tetto nonché dalla determinazione della quota di mercato a carico del titolare di AIC.

Una prima novità rilevante rispetto ai precedenti criteri di valutazione dell'innovatività riguarda il trattamento delle patologie ad alta prevalenza. Nello specifico, questi criteri di valutazione dell'innovatività terapeutica sono applicabili limitatamente a quelle specifiche indicazioni relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico (individuato dalla CSE in base alla prevalenza della malattia). La valutazione deve tener conto anche delle restrizioni d'uso effettive previste dalla scheda tecnica e dalle condizioni di rimborsabilità. Così formulata, questa specificazione risulta più

[3] Ogni eventuale modificazione dell'indicazione terapeutica alla quale era stato già attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica, successivamente intervenuta nel processo di autorizzazione, rientra nel periodo di validità di 36 mesi originariamente riconosciuto. Ogni eventuale ulteriore nuova indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo perviene all'AIFA entro il decimo anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività, può essere valutata ai fini dell'accesso al Fondo Farmaci Innovativi per una durata massima di 36 mesi. Ogni eventuale autorizzazione di un nuovo medicinale, la cui indicazione terapeutica è stata già riconosciuta come innovativa in relazione ad un'altra specialità medicinale appartenente alla medesima classe (che condivide il meccanismo d'azione), potrà eventualmente beneficiare dell'accesso al Fondo Farmaci Innovativi per il periodo residuale dei 36 mesi originariamente fissato (Innovatività di classe).

dettagliata rispetto al documento iniziale sottoposto a consultazione (che già esplicitava questo tema seppure in modo meno approfondito), ma ancora poco chiara, lasciando spazio all'interpretazione discrezionale su quale sia una indicazione ad alta, media o bassa prevalenza (cfr 8.4).

Il secondo cambiamento riguarda il riconoscimento specifico della ricerca clinica condotta in Italia. In un passaggio chiave, la nuova determina prevede che la generalizzabilità dei risultati – e dunque la qualità delle prove – possa essere considerata maggiore qualora il piano di sviluppo del farmaco sia stato progettato e condotto nel contesto assistenziale italiano. È una novità significativa anche rispetto al documento in consultazione, che non contemplava così dettagliatamente questo aspetto, e dovrebbe, in qualche modo, rappresentare un incentivo implicito alla promozione della sperimentazione nazionale.

Anche sul fronte del vantaggio terapeutico aggiunto sono emersi importanti novità. In particolare, la determina AIFA conferma le fondamenta già poste a marzo con la consultazione ma introduce, anche in questo caso, delle precisazioni importanti. Infatti, rispetto al documento preliminare in consultazione, la versione definitiva integra esplicitamente la possibilità di considerare nella valutazione anche i *Patient-Reported Outcome Measures* (PROMs) e i *Patient-Reported Experience Measures* (PREMs), a condizione che siano strumenti validati e rilevanti. Si tratta di un'apertura culturale e regolatoria non trascurabile, che allinea l'Italia alle *best practice* europee e internazionali e valorizza il ruolo attivo del paziente nella definizione del beneficio clinico percepito.

Infine, come nel documento in consultazione, anche la Determina 966-2025 dedica una sezione ai medicinali antimicrobici per infezioni da germi multiresistenti. La determina, difatti, ribadisce quanto già anticipato a marzo, cioè che per tali prodotti non si procede alla valutazione dell'innovatività secondo i tre domini tradizionali, ma si applicano criteri ad hoc, tra cui la classificazione AWaRe dell'OMS e l'attività verso patogeni prioritari. Tale approccio si muove in coerenza con l'obiettivo di supportare l'introduzione di antibiotici strategici nell'ottica della *stewardship* antimicrobica. Infatti, la spesa per tali specialità medicinali non concorre al calcolo dell'ammontare della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti ai fini del rilevamento dell'eventuale superamento del rispettivo tetto, ma, come già previsto nella L. 207/2024, viene finanziata attraverso il sistema del FFI nei limiti di 100 milioni di euro all'anno (cfr 8.2.3)

Nel suo insieme, la Determina 966-2025 non solo conferma la visione metodologica introdotta nella proposta di marzo, ma ne rafforza l'applicabilità e ne corregge alcune ambiguità interpretative. Ad ogni modo, persistono ancora alcuni elementi che richiedono l'attenzione del *policymaker* e che potrebbero essere riconsiderati in un'ottica di maggior beneficio al governo dell'innovazione tecnologica in ambito farmaceutico (cfr 8.4).

8.3 L'innovatività in ambito farmaceutico

8.3.1 Trend di sviluppo in ambito farmaceutico

Negli ultimi anni, l'industria farmaceutica ha attraversato profonde trasformazioni, spinte da una serie di dinamiche globali e da cambiamenti sostanziali nei paradigmi di ricerca e sviluppo (R&D). Il tradizionale modello di innovazione, prevalentemente orientato all'allungamento della vita, si è rivelato gradualmente insostenibile rispetto alle risorse collettive disponibili e alla crescente pressione economica sui sistemi sanitari. Di conseguenza, si sta gradualmente affiancando un nuovo paradigma di innovazione, focalizzato non solo sulla sopravvivenza, ma soprattutto sul recupero e il prolungamento della buona salute, puntando a ridurre l'impatto complessivo delle malattie sulla società e sull'economia. Questo nuovo paradigma promuove un effetto clinico più marcato sul miglioramento della salute dei pazienti, incentivando terapie che consentano un rapido recupero delle capacità lavorative e produttive, generando così un impatto positivo sul sistema economico e sui fornitori di servizi sanitari. In termini concreti, ciò si manifesta con un crescente quantitativo di lanci di nuovi farmaci per indicazioni di malattia precoce e con un crescente investimento legato a prodotti di diagnostica e di prevenzione. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'accettabilità da parte dei pazienti, in termini di preferenze e comportamenti, e al valore assicurativo e delle *real-option* dei nuovi trattamenti. Tra le aree terapeutiche che dominano gli investimenti e la ricerca, l'oncologia mantiene ancora una posizione di rilievo ma non è più l'area che domina in modo incontrastato l'interesse di ricerca del mercato farmaceutico. Infatti, in aggiunta alla parziale riallocazione delle attività di ricerca in oncologia verso le terapie per tumori in fase precoce, altre aree iniziano a dominare il panorama della ricerca: tra queste, emergono principalmente l'immunologia, l'obesità, le malattie rare e le terapie avanzate, come la terapia genica e cellulare.

In relazione a questo riposizionamento delle aree di ricerca e innovazione, si segnala un'inversione, ormai in atto da alcuni anni, dell'approccio strategico di portafoglio da parte delle principali imprese del settore. Infatti, se fino al 2010-2015 il mercato era caratterizzato da una crescente diversificazione, con molte imprese attive nel *Merger & Acquisition* (M&A) di realtà complementari rispetto al proprio portafoglio, nell'ultimo decennio si è assistito ad una progressiva rifocalizzazione su uno o pochi *core-business*. Un fattore degno di nota è che tale rifocalizzazione non ha soltanto riguardato aree di patologia (es. oncologia) ma più di frequente, e in proporzione crescente, processi comuni a più condizioni (es. processi infiammatori). Ciò ha permesso alle imprese, da un lato, di ridurre la pressione competitiva, attivandosi su nicchie di mercato più specifiche e meno popolate, e dall'altro di dedicare più risorse

alla ricerca dell'eccellenza in uno specifico contesto, fornendo al contempo ai propri interlocutori dei partner maggiormente riconoscibili e impegnati alla soluzione di problemi. Non a caso, le imprese che hanno compiuto tale scelta hanno registrato un aumento della produttività in R&D che, secondo recenti analisi di Boston Consulting Group, risulta del 25-40% superiore per le aziende che adottano una strategia di focalizzazione rispetto ad una diversificazione generalizzata (Bleys, Khan, Wu, *et al.*, 2025). Alcuni esempi significativi di tale scelta strategica sono rappresentati da aziende con un forte posizionamento nei disturbi metabolici, tra cui il diabete, o con una crescente concentrazione nell'immunologia. Tale approccio consente alle aziende di adottare una maggiore chiarezza strategica, specializzazione e differenziazione, sebbene le esponga a rischi derivanti da cambiamenti improvvisi nel mercato di riferimento.

Un altro cambiamento rilevante è rappresentato dalla crescente adozione delle tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale (IA) nel processo di R&D farmaceutico. L'applicazione di queste tecnologie, in particolare attraverso strumenti come il *digital twin* (ovvero, la rappresentazione virtuale di una persona, di un prodotto o di un processo), consente una più accurata predizione del comportamento delle molecole candidate, un'ottimizzazione del disegno degli studi clinici e una significativa riduzione dei tempi necessari allo sviluppo dei farmaci. Questo scenario, che sta diventando rapidamente una realtà consolidata nell'industria farmaceutica, promette anche di contribuire al contenimento dei costi associati all'innovazione, aumentando l'efficienza complessiva dei processi di ricerca clinica.

Infine, l'ambiente di mercato è fortemente influenzato dalle aspettative di *payers* e *policymaker*, i quali richiedono sempre più frequentemente evidenze di efficacia nel mondo reale (*real-world evidence*, RWE) per decisioni di rimborso, spingendo le aziende verso modelli di *business* che dimostrino concretamente il valore clinico ed economico dei nuovi farmaci. Questo cambiamento contribuisce ad orientare l'innovazione verso risultati clinici tangibili e sostenibili nel lungo periodo. In parallelo, le aziende farmaceutiche sono chiamate a dimostrare il valore dei propri prodotti in contesti economici sempre più rigorosi, con una pressione crescente sui prezzi e una maggiore attenzione all'efficienza e all'equità nell'allocazione delle risorse sanitarie. Il cambiamento del paradigma di innovazione, infatti, deve interfacciarsi con le aspettative e le priorità percepite dal lato della domanda, in particolare con il modo in cui esse vengono espresse da programmatori e pagatori. È quindi utile classificare in modo sintetico le diverse interpretazioni del concetto di innovatività, distinguendole in base alla prospettiva con cui si misura il livello di cambiamento introdotto rispetto alla situazione precedente.

8.3.2 Differenze tra farmaco nuovo e farmaco innovativo

In questa sede, è opportuno distinguere innanzitutto il concetto di novità e quello di innovatività, poiché non tutti i farmaci nuovi sono necessariamente innovativi. Un "farmaco nuovo" si riferisce semplicemente all'introduzione sul mercato di una nuova molecola, una nuova formulazione o una nuova indicazione terapeutica, senza necessariamente rappresentare un progresso significativo rispetto alle alternative già disponibili. Non c'è una definizione ufficiale di "nuovo" e, ad esempio, non è chiaro se un farmaco sia definibile come "nuovo" fino a 12 mesi (o altro orizzonte temporale) dalla sua introduzione, o se la "novità" rimanga tale finché non avviene un lancio successivo sulla medesima indicazione. Tuttavia, ciò che rileva è la definizione differenziale tra nuovo-non innovativo e nuovo-innovativo.

Infatti, il termine "farmaco innovativo" implica un avanzamento importante rispetto allo stato dell'arte e può essere declinato in diverse dimensioni:

- *Innovatività tecnologica:* rappresenta il grado di avanzamento nella tecnologia di base per cui si caratterizza il farmaco, come un nuovo meccanismo d'azione o un paradigma tecnologico completamente nuovo, ad esempio le terapie geniche o le terapie cellulari avanzate. Un esempio di questa categoria sono le terapie basate sull'*editing* genetico come CRISPR-Cas9, che aprono scenari radicalmente differenti nella cura di malattie rare e complesse.
- *Innovatività clinica:* indica il livello di discontinuità generato negli effetti clinici, ovvero un significativo miglioramento rispetto alle terapie esistenti in termini di efficacia, vincolate al mantenimento di un profilo adeguato in termini di sicurezza e tollerabilità. Si tratta di farmaci che determinano un cambio radicale nella gestione clinica dei pazienti, portando vantaggi evidenti rispetto agli standard terapeutici preesistenti.
- *Innovatività sostanziale:* è un concetto più ampio rispetto a quello clinico, che include anche gli effetti positivi complessivi che il farmaco produce sull'organizzazione dei servizi sanitari, sulla spesa e sui consumi sanitari, nonché sulla produttività generale del sistema sanitario e socioeconomico. Ad esempio, un farmaco che consente il trattamento domiciliare di una patologia precedentemente gestita soltanto in ospedale, riduce significativamente i costi organizzativi per il SSN, contiene i costi di trasporto e l'assenteismo lavorativo per il paziente, e aumenta l'efficienza del sistema. Oppure, un farmaco che consente un trattamento precoce di una condizione precedentemente trattata solo in forma grave consente di ridurre il peso economico e organizzativo prospettico per il SSN, aumentando al contempo la probabilità che la persona in cura rimanga produttiva per il sistema economico.
- *Innovatività legale*: rappresenta un riconoscimento formale transitorio attribuito da autorità regolatorie e di *Health Technology Assessment* (HTA),

che permette benefici quali un accesso più rapido al mercato, procedure di rimborso accelerate e preferenziali o finanziamenti dedicati. Tale riconoscimento spesso riflette una combinazione delle dimensioni precedentemente indicate, basandosi su criteri ben definiti e scientificamente fondati. Definire con precisione questi criteri è fondamentale per rendere il processo prevedibile per entrambe le parti coinvolte nel mercato, riducendo al minimo la componente negoziale e mantenendo al tempo stesso la flessibilità necessaria. Se così non fosse, infatti, i criteri di ammissibilità verrebbero sostanzialmente definiti ex-novo caso per caso, creando problemi di equità nell'ammissione all'innovatività. Un'altra caratteristica dell'innovatività legale è la sua transitorietà. Sebbene anche le altre definizioni di innovatività abbiano carattere naturalmente transitorio (un farmaco non può rappresentare la frontiera dell'innovazione per un tempo indefinito), in questo caso la durata deve essere esplicitata e comportare delle conseguenze (tipicamente, la perdita dei benefici legati all'innovatività legale). Essendo impossibile, tuttavia, standardizzare i tempi di obsolescenza, perché questi dipendono da numerosi fattori, inclusa la velocità con cui vengono rese disponibili alternative terapeutiche migliori, il periodo predefinito non coincide quasi mai con la permanenza del farmaco sulla frontiera dell'innovazione e, pertanto, è possibile che il farmaco diventi tecnologicamente, clinicamente o sostanzialmente obsoleto prima che scada l'innovatività legale o, viceversa, che un farmaco perda il requisito per il raggiungimento del termine ma rimanga la soluzione più innovativa comunque disponibile sul mercato.

La distinzione tra farmaco "nuovo" ma "non innovativo" e farmaco "innovativo" è cruciale anche sotto il profilo economico e regolatorio. I farmaci che soddisfano criteri di innovatività sono spesso soggetti a percorsi regolatori specifici, che consentono un'accelerazione dei processi di autorizzazione e rimborsabilità, garantendo ai pazienti un accesso più tempestivo a trattamenti potenzialmente trasformativi. Al contrario, i farmaci nuovi, ma non innovativi, seguono percorsi standard e devono confrontarsi più rigorosamente con alternative già presenti sul mercato, spesso con una minore possibilità di ottenere un prezzo più remunerativo.

8.3.3 Valutazione dell'innovatività in ambito farmaceutico: un confronto internazionale

Nel contesto europeo, esistono diversi strumenti finalizzati a facilitare l'accesso precoce ai farmaci che rappresentano un potenziale avanzamento terapeutico rilevante. Tra questi si distingue il PRIME *Scheme* (*PRIority MEdicines*) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), introdotto nel 2016, che offre

supporto regolatorio rafforzato e accelerazione nella valutazione dei dossier per i farmaci che rispondono a bisogni terapeutici non soddisfatti. PRIME è pensato per ottimizzare e accelerare lo sviluppo di farmaci che offrono un vantaggio terapeutico significativo o che rispondono a un bisogno medico non soddisfatto, attraverso interazioni precoci e rafforzate con i comitati scientifici dell'EMA, assistenza alla generazione di dati clinici solidi, accesso facilitato alla valutazione accelerata per l'AIC. Tale programma si affianca ad altri strumenti regolatori europei, come la procedura di Autorizzazione Condizionata all'Immissione in Commercio (*Conditional Marketing Authorisation*) e la Valutazione Accelerata (*Accelerated assessment*), che rappresentano esempi di innovatività regolatoria volti a facilitare l'accesso precoce a farmaci innovativi, in particolare in aree di bisogno medico insoddisfatto. Sebbene tali procedure non abbiano implicazioni automatiche o vincolanti in ambito nazionale per quanto riguarda la determinazione del prezzo e il rimborso, esse possono influenzare indirettamente i processi decisionali delle autorità nazionali – come l'AIFA in Italia – contribuendo a una più rapida valutazione del valore terapeutico del farmaco e all'eventuale accesso a percorsi negoziali o strumenti regolatori specifici.

Tuttavia, la definizione formale e vincolante dell'innovatività legale – intesa come status attribuito dalle autorità nazionali che dà accesso a vantaggi economici e procedurali – resta prerogativa dei singoli Stati Membri. Di seguito si propone un confronto tra cinque Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), evidenziando le principali caratteristiche dei rispettivi sistemi.

Italia

Il sistema italiano, aggiornato nel 2025 con la Determina AIFA 966-2025, prevede il riconoscimento dell'innovatività a livello di indicazione terapeutica, basandosi su tre criteri: bisogno terapeutico, vantaggio terapeutico aggiunto e qualità delle prove (modello GRADE). Il riconoscimento pieno dà accesso automatico al FFI, all'inserimento prioritario nei prontuari regionali e alla sospensione temporanea di sconti obbligatori. La durata è di 36 mesi. Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi precedenti.

Francia

In Francia non esiste una designazione formale di "farmaco innovativo" come in Italia, ma l'innovatività è valutata attraverso il sistema dell'*Amélioration du Service Médical Rendu* (ASMR), che misura il valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili. I farmaci con ASMR di livello I, II o III – indicativi di un beneficio clinico significativo – possono accedere a prezzi più elevati e a percorsi negoziali preferenziali. Inoltre, per i farmaci destinati a malattie gravi, rare o prive di alternative, è previsto l'accesso precoce tramite

il programma "*Accès précoce*" (che ha sostituito il sistema ATU[4]), che consente la rimborsabilità prima dell'autorizzazione formale all'immissione in commercio. Tuttavia, a differenza dell'Italia, in Francia non esistono fondi dedicati esclusivamente ai farmaci innovativi.

Germania

Il sistema tedesco, gestito dal Comitato Federale Congiunto (*Gemeinsamer Bundesausschuss*, G-BA) con il supporto dell'Istituto per la Qualità e l'Efficienza nell'Assistenza Sanitaria (*Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen*, IQWiG), prevede una valutazione precoce del beneficio aggiuntivo ("*added benefit*") del nuovo farmaco rispetto alla terapia standard di riferimento, da effettuarsi entro sei mesi dall'immissione in commercio. Il giudizio del GBA incide direttamente sulla negoziazione del prezzo con l'Associazione Nazionale dei Fondi di Assicurazione Sanitaria Obbligatoria (GKV-*Spitzenverband*) e può assumere i seguenti livelli: i) maggiore, ii) considerevole, iii) minore, iv) non quantificabile o v) assente. In Germania non esistono fondi dedicati né etichettature ufficiali per l'innovatività, ma il valore clinico riconosciuto si traduce immediatamente in un margine negoziale sul prezzo.

Spagna

In Spagna non esiste una designazione formale di "farmaco innovativo" né un meccanismo strutturato che conferisca vantaggi regolatori automatici. Il concetto di valore terapeutico aggiunto viene considerato all'interno dei Rapporti di Posizionamento Terapeutico (*Informes de Posicionamiento Terapéutico*, IPT), coordinati dall'Agenzia Spagnola dei Medicinali (AEMPS), ma senza etichettature ufficiali o percorsi accelerati codificati. Dopo l'annullamento del progetto REvalMED[5] nel 2023, la valutazione HTA è stata ricondotta all'interno di un processo gestito esclusivamente da AEMPS, con priorità eventualmente attribuite a farmaci orfani o destinati a patologie gravi. Ogni decisione su prezzo e rimborso viene negoziata caso per caso con la *Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos* (CIPM), senza l'ausilio di fondi dedicati o corsie preferenziali strutturate come in altri Paesi.

[4] L'ATU (*Autorisation Temporaire d'Utilisation*) era un programma francese che consentiva l'uso e il rimborso temporaneo di farmaci ancora privi di AIC, in presenza di gravi patologie senza alternative terapeutiche. È stato sostituito nel 2021 dal nuovo sistema di *Accès précoce*, che ne ha razionalizzato e strutturato i criteri di accesso e gestione.

[5] REvalMED era un progetto di riforma della valutazione HTA in Spagna, introdotto nel 2020 per centralizzare e sistematizzare l'elaborazione dei rapporti di posizionamento terapeutico. È stato dichiarato nullo dalla giustizia amministrativa nel 2023 per vizi formali e superamento delle competenze normative dell'AEMPS, portando al ritorno a un modello decentralizzato e meno strutturato.

Regno Unito (Inghilterra)
Nel Regno Unito, l'accesso ai farmaci è regolato dal *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE), che valuta il rapporto costo-efficacia delle nuove terapie attraverso l'ICER (*Incremental Cost-Effectiveness Ratio*), espresso in QALY (*Quality-Adjusted Life Years*). In genere, i farmaci sono raccomandati se l'ICER rientra in una soglia compresa tra £20.000 e £30.000 per QALY guadagnato. Tuttavia, per farmaci destinati a condizioni ultra-rare, è previsto un percorso separato nell'ambito del programma *Highly Specialised* Technologies (HST), che applica soglie ICER più elevate, fino a £100.000–£300.000 per QALY. Esistono inoltre meccanismi di accesso condizionato come i *Managed Access Agreements*, che consentono l'uso provvisorio del farmaco contestualmente ad una raccolta dati *real-world*, e il *Cancer Drugs Fund*, che offre accesso rapido e temporaneo ai farmaci oncologici in attesa di valutazione definitiva. Il concetto di innovatività nel sistema britannico è quindi strettamente legato al valore economico sostenibile e al beneficio clinico, piuttosto che a un'etichettatura formale o a criteri fissi di innovazione terapeutica.

Il confronto tra i principali sistemi europei evidenzia una notevole eterogeneità nell'approccio all'innovatività farmaceutica, sia sul piano regolatorio sia su quello economico. L'Italia rappresenta un caso unico per la presenza di fondi dedicati e criteri formali vincolanti per il riconoscimento dell'innovatività, con impatti diretti e automatici su prezzo, rimborsabilità e accesso. Al contrario, Paesi come Francia, Spagna e Germania si basano su valutazioni del valore terapeutico aggiunto o del beneficio clinico, senza prevedere una designazione giuridica di innovatività né strumenti economici strutturati e dedicati, pur riconoscendo in modo più o meno esplicito la rilevanza clinica e strategica di alcune terapie. Il Regno Unito adotta un approccio centrato sulla sostenibilità economica e sull'efficienza allocativa, con soglie di costo-efficacia flessibili per condizioni ad alta complessità clinica e strumenti specifici per la gestione dell'incertezza, ma anch'esso privo di una formalizzazione legale del concetto di farmaco innovativo.

Pertanto, solo l'Italia ha istituzionalizzato l'innovatività legale come categoria regolatoria ed economica autonoma, mentre negli altri Paesi essa è incorporata in modo variabile nei processi valutativi, senza effetti automatici su prezzo o accesso. Questa diversità riflette differenti bilanciamenti tra esigenze di sostenibilità, rapidità di accesso e riconoscimento del valore terapeutico nell'ambito delle politiche sanitarie nazionali.

8.4 Raccomandazioni per il policy maker

L'aggiornamento del sistema di valutazione dell'innovatività terapeutica rappresenta oggi una leva cruciale per coniugare accesso tempestivo all'innovazio-

ne, sostenibilità del sistema e attrattività per la ricerca. La recente revisione dei criteri AIFA ha introdotto elementi di maggiore strutturazione, ma persistono aree di miglioramento e rischi di incertezza interpretativa. Di seguito alcune raccomandazioni rivolte ai decisori pubblici.

1. Superare la logica dei fondi dedicati come strumento strutturale di finanziamento dell'innovazione

L'Italia rappresenta un unicum in Europa per l'adozione di fondi collettivi vincolati al riconoscimento di innovatività e questo può generare una competizione per le risorse tra farmaci che, invece, si intende facilitare nell'accesso[6]. Riteniamo auspicabile che ogni farmaco valutato e rimborsato abbia un finanziamento dedicato e non in competizione. Tale logica dovrebbe a maggior ragione applicarsi ai farmaci innovativi. Questa impostazione faciliterebbe anche il percorso di uscita dallo status di innovatività, rendendo più agile la previsione del nuovo corso di finanziamento, invece che far confluire l'ex-innovativo in un fondo (il tetto sugli acquisti diretti) già palesemente incapiente. Questa raccomandazione non è direttamente legata ai nuovi criteri di innovatività ma è piuttosto un invito a mettere in prospettiva di medio termine il modo in cui tale innovatività produce conseguenze per imprese e attori pubblici.

2. Rafforzare la precisione, la scientificità e la verificabilità dei criteri di innovatività

La nuova Determina AIFA 966-2025 rappresenta un passo avanti, ma alcuni passaggi, in particolare quelli legati alla definizione dell'impatto epidemiologico e alla classificazione degli esiti, restano ambigui o suscettibili di interpretazioni discrezionali. È opportuno che i criteri siano non solo trasparenti e operativi, ma anche scientificamente fondati, validati e coerenti con standard metodologici internazionali, per garantire equità, ripetibilità e prevedibilità del processo decisionale.

3. Valorizzare la sperimentazione clinica nazionale come scelta strategica

Il riconoscimento di una maggiore trasferibilità delle evidenze generate in Italia è un elemento di novità rilevante. Tuttavia, tale valorizzazione non deve servire ad abbassare i requisiti scientifici per l'accesso all'innovatività, rendendo possibile produrre evidenze meno qualitative ma bilanciandole con il fatto che i trial sono stati effettuati in Italia. Deve, al contrario, costituire una scelta strategica lungimirante per sostenere la competitività del sistema Paese. In altri termini, la volontà di investire sul sistema Italia potrà attrarre sperimenta-

[6] In Italia tale concorrenza è indiretta in quanto l'eventuale sfondamento viene posto a carico dei prodotti non innovativi ma potrebbe comunque pesare su aziende che hanno in portafoglio contemporaneamente farmaci innovativi e non innovativi.

zioni di qualità, mettendo nel mirino della ricerca gli *unmet need* prioritari per l'Italia, con il risultato di sviluppare innovazioni degne del riconoscimento di innovatività.

4. Non escludere rigidamente l'innovatività nelle patologie ad alta prevalenza
Se da un lato è ragionevole concentrare risorse su aree cliniche prioritarie, dall'altro è necessario evitare esclusioni predefinite e generalizzate per patologie ad alta prevalenza, che potrebbero comunque beneficiare di innovazioni trasformative. È emblematico il caso dei farmaci per l'epatite C, che nel 2015 hanno determinato una svolta clinica epocale e sono stati la ragione originaria della creazione del primo fondo dedicato *ad-hoc* per i farmaci innovativi. Un approccio troppo rigido rischierebbe di escludere interventi che, pur in aree ad alta diffusione, apportano benefici clinici, organizzativi ed economici significativi.

5. Coordinare il sistema nazionale con il nuovo Regolamento europeo HTA
A seguito dell'implementazione del Regolamento (UE) 2021/2282 sull'HTA, è essenziale che i processi nazionali – compresi quelli per il riconoscimento dell'innovatività – siano coerenti e interoperabili con la valutazione clinica congiunta (*Joint Clinical Assessment*, JCA) europea, in vigore dal gennaio 2025 per i farmaci oncologici e le terapie avanzate. Questo coordinamento deve riguardare criteri, tempistiche, documentazione e strumenti valutativi, al fine di evitare sovrapposizioni, ritardi o disallineamenti che potrebbero scoraggiare gli investimenti industriali e indebolire il ruolo dell'Italia nei processi decisionali europei.

8.5 Bibliografia

AIFA. (2017, settembre 12). Determina 1535/2017. Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi ai sensi dell'articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. https://www.aifa.gov.it/documents/20142/516919/Determina_criteri_classificazione_farmaci_innovativi.pdf

AIFA. (2024, marzo 5). Aggiornamento del Prontuario della continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT) per il transito dal regime di classificazione «A-PHT» alla fascia «A» di medicinali afferenti a specifiche classi farmacologiche. (Determina n. 3/2024). (24A02347) (GU Serie Generale n.108 del 10-05-2024). https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-05-10&atto.codiceRedazionale=24A02347&elenco30giorni=false

AIFA. (2025a, aprile 14). Tavolo tecnico AIFA-Regioni: Condiviso metodo di

calcolo sull'impatto economico di classe delle glifozine. https://www.aifa.gov.it/documents/20142/2694929/Comunicato_AIFA_20-2025.pdf

AIFA. (2025b, luglio 9). Allegato 1—Criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica e sulla gestione degli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti. https://www.aifa.gov.it/documents/20142/2971622/Allegato-1_alla_Det-Pres-966-2025.pdf

AIFA. (2025c, luglio 9). Determina Pres. 966/2025—Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e degli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 281-292.

Amoroso, N., Armeni, P., Costa, F., Jommi, C., & Otto, M. (2016). Il governo dell'assistenza farmaceutica in Italia: Possibili traiettorie di cambiamento. In Rapporto OASI - Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema sanitario Italiano. EGEA. https://cergas.unibocconi.eu/sites/default/files/files/Capitolo-10_2016.pdf

Armeni, P., Callea, G., Costa, F., Malandrini, F., Otto, M., Segantin, G., Sirena, P., & Tarricone, R. (2023). Il payback come misura di contenimento della spesa per farmaci e dispositivi medici. In Rapporto OASI (Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano. EGEA. https://cergas.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/0044_Rapporto_OASI_2023_Capitolo_17.pdf

Armeni, P., Cavallaro, L., Costa, F., Malandrini, F., & Otto, M. (2024). Politiche del farmaco: Approfondimento sul Value Framework per i farmaci. In Rapporto OASI (Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano. EGEA. https://cergas.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/08_Oasi_2024_Politiche_del_farmaco.pdf

Armeni, P., Costa, F., Otto, M., Jommi, C., Malandrini, F., & Tarantola, A. (2023). L'evoluzione del finanziamento dei farmaci in Italia. In Rapporto OASI (Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano. EGEA. https://cergas.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/0029_Rapporto_OASI_2023_Capitolo_8.pdf

Bleys, M., Khan, B., Wu, J., & Chandran. (2025). Biopharma Trends 2025—Focusing on Innovation amid Complexity. Boston Consulting Group (BCG). https://web-assets.bcg.com/80/70/7fee493b4991934742b68e87dc3d/biopharma-trends-focusing-on-innovation-amid-complexity-jan-2025.pdf